Obezita v ambulancii všeobecného lekára: prečo ju treba liečiť ako chronické ochorenie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 18.05.2026



Ilustračná scéna. Jednorazová snaha nestačí — obezita si žiada rovnaký režim sledovania ako iné chronické choroby.

Obezita patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia v každodennej ambulantnej praxi. Nie je iba otázkou vzhľadu, disciplíny alebo osobnej motivácie. Ide o komplexné metabolické ochorenie, ktoré významne zvyšuje riziko diabetu 2. typu, arteriálnej hypertenzie, dyslipidémie, chronickej choroby obličiek, kardiovaskulárnych ochorení, steatózy pečene, spánkového apnoe, degeneratívnych ochorení kĺbov a niektorých nádorových ochorení.

Obezita nie je zlyhanie vôle

Jednou z najväčších prekážok účinnej liečby obezity je predstava, že ide najmä o nedostatok pevnej vôle. V skutočnosti je regulácia telesnej hmotnosti výsledkom zložitej súhry genetických faktorov, hormonálnych signálov, apetítu, energetického výdaja, psychiky, spánku, sociálneho prostredia, liekov a pridružených ochorení.

Pacient s obezitou často potrebuje dlhodobú odbornú podporu, nie jednoduchú radu „menej jesť a viac sa hýbať“. Takáto rada je síce intuitívna, ale sama osebe býva nedostatočná. Úlohou lekára je pomôcť pacientovi nájsť realistický, bezpečný a udržateľný plán.

Diagnostika sa nezačína a nekončí pri BMI

Body mass index je praktický orientačný ukazovateľ, no nehovorí všetko. Pri hodnotení pacienta s nadváhou alebo obezitou je dôležité posúdiť aj obvod pása, krvný tlak, glykemický profil, lipidový profil, pečeňové parametre, renálne funkcie a prítomnosť albuminúrie. Vhodné je pátrať po príznakoch spánkového apnoe, bolestiach kĺbov, depresívnych alebo úzkostných prejavoch a po liekoch, ktoré môžu prispievať k nárastu hmotnosti.

Z klinického hľadiska je kľúčové určiť, či už obezita spôsobila orgánové alebo metabolické komplikácie. Pacient s

rovnakým BMI môže mať veľmi rozdielne riziko podľa toho, či má normálny metabolický profil, alebo už prítomný diabetes, hypertenziu, albuminúriu, steatózu pečene či kardiovaskulárne ochorenie.

Ako otvoriť tému hmotnosti

Rozhovor o hmotnosti musí byť citlivý, ale nie vyhýbavý. Pacient má cítiť, že lekár nerieši jeho vzhľad, ale zdravie. Praktické je začať jednoduchou otázkou, či pacient súhlasí s tým, aby sa hovorilo o hmotnosti a jej vplyve na zdravie. Takýto prístup znižuje obrannú reakciu a vytvára priestor pre spoluprácu.

Dôležité je používať neutrálny jazyk. Namiesto výčitiek je vhodné hovoriť o zdravotnom riziku, možnostiach liečby a konkrétnych cieľoch. Aj malá redukcia hmotnosti môže mať klinický význam. Pokles hmotnosti o 5 až 10 percent môže zlepšiť krvný tlak, glykémiu, triglyceridy, stukovatenie pečene a záťaž pohybového aparátu.

Základom je komplexný plán

Liečba obezity by mala stáť na viacerých pilieroch. Patrí sem úprava stravy, pravidelná pohybová aktivita, zlepšenie spánku, práca so stresom, liečba pridružených ochorení a podľa potreby psychologická podpora. Režimové opatrenia majú byť konkrétne, merateľné a prispôsobené možnostiam pacienta.

V praxi je vhodnejšie stanoviť menší, ale dosiahnuteľný cieľ, než vytvoriť ambiciózny plán, ktorý pacient po niekoľkých týždňoch opustí. Dôležitá je pravidelná kontrola, povzbudenie, úprava postupu a práca s relapsmi. Obezita má chronický priebeh a návrat hmotnosti po úspešnej redukcii nie je zriedkavý. Neznamená to zlyhanie pacienta, ale potrebu pokračovať v liečbe.

Farmakoterapia má svoje miesto

Moderný prístup k obezite zahŕňa aj farmakologickú liečbu, ak je indikovaná. Lieky na redukciu hmotnosti nie sú náhradou životosprávy, ale môžu významne pomôcť pacientom, u ktorých samotné režimové opatrenia nestačia. Pri výbere liečby treba zohľadniť BMI, pridružené ochorenia, kardiometabolické riziko, kontraindikácie, toleranciu a dostupnosť liečby.

V posledných rokoch sa výrazne rozšírili možnosti liečby založené na ovplyvnení inkretínových mechanizmov. Tieto lieky môžu pomáhať pri redukcii hmotnosti, zlepšení glykemickej kontroly a u niektorých skupín pacientov aj pri znižovaní kardiometabolického rizika. Výber konkrétneho lieku však patrí do rúk lekára a má vychádzať z platných odporúčaní, schválených indikácií a individuálneho profilu pacienta.

Kedy myslieť na špecialistu

Všeobecný lekár má pri manažmente obezity zásadnú úlohu, ale nie každý pacient má zostať iba v primárnej starostlivosti. Odoslanie k špecialistovi je vhodné pri ťažkej obezite, rýchlom náraste hmotnosti, podozrení na endokrinnú príčinu, komplikovanom diabete, pokročilej chronickej chorobe obličiek, srdcovom zlyhávaní, závažnej steatóze pečene, poruche príjmu potravy alebo pri zvažovaní bariatrickej liečby.

Bariatrická a metabolická chirurgia môže byť u vybraných pacientov veľmi účinnou liečebnou možnosťou. Nejde o kozmetický zákrok, ale o intervenciu s potenciálom zlepšiť metabolický stav, diabetes, hypertenziu, spánkové apnoe a celkovú prognózu. Vyžaduje však dôsledný výber pacienta, prípravu a dlhodobé sledovanie.

Praktický cieľ: menej komplikácií, lepšia kvalita života

Úspech liečby obezity sa nemá merať iba číslom na váhe. Dôležité je zlepšenie zdravotného rizika, funkčnej zdatnosti, kvality života, krvného tlaku, glykémie, lipidov, pečeňových parametrov, renálnych ukazovateľov a celkovej pohyblivosti. U niektorých pacientov je realistickým úspechom stabilizácia hmotnosti a zastavenie ďalšieho priberania.

Z pohľadu nefrológie má redukcia hmotnosti osobitný význam. Obezita prispieva k hyperfiltrácii, albuminúrii, progresii chronickej choroby obličiek a zhoršeniu kardiovaskulárneho rizika. Preto by sa mala vnímať aj ako súčasť prevencie poškodenia obličiek.

Záver

Obezita v ambulancii všeobecného lekára nie je okrajová téma. Je to každodenná klinická výzva a zároveň príležitosť na prevenciu diabetu, kardiovaskulárnych ochorení, chronickej choroby obličiek a ďalších komplikácií. Účinný manažment si vyžaduje rešpektujúcu komunikáciu, systematické vyšetrenie rizík, realistický plán a dlhodobé sledovanie.

Najdôležitejšie je prestať vnímať obezitu ako jednoduchý dôsledok zlých rozhodnutí. Je to chronické ochorenie, ktoré si zaslúži odbornú diagnostiku, liečbu a kontinuálnu podporu.

Zdroj: STREAMED UP, „Adipositas in der Hausarztpraxis 2026“. Dostupné na: https://streamed-up.com/video/adipositas-in-der-hausarztpraxis-2026

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=obezita-v-ambulancii-vseobecneho-lekara-preco-ju-treba-liecit-ako-chronicke-ochorenie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.